



Fachbereiche EU 6 und WD 8

**Regelungsrahmen betreffend Kohortenstudien innerhalb der
Humanarzneimittelüberwachung**

Regelungsrahmen betreffend Kohortenstudien innerhalb der Humanarzneimittelüberwachung

Aktenzeichen: EU 6-30000-007-0008; WD 8-30000-0006-0005
Abschluss der Arbeit: 5. August 2026
Fachbereich: EU 6: Europa- und Völkerrecht, Auswärtiges und Sicherheit
WD 8: Gesundheit, Familie, Bildung und Forschung, Umwelt

Die Arbeiten des Fachbereichs Europa- und Völkerrecht, Auswärtiges und Sicherheit geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Fragestellung, Begriffsbestimmung und Darstellungsumfang (EU 6)	4
2.	Unionsrechtliche Vorgaben (EU 6)	5
2.1.	Arzneimittelüberwachung nach dem Unionsrecht	5
2.2.	Unionsrechtliche Regelungen betreffend Kohortenstudien	6
2.2.1.	Überblick	7
2.2.2.	Regelungsrahmen in Bezug auf nicht-interventionelle PASS	8
2.2.2.1.	Nicht zentral zugelassene Arzneimittel – RL 2001/83	8
2.2.2.2.	Zentral zugelassene Arzneimittel – VO 726/2004	9
2.2.3.	Regelungsrahmen in Bezug auf interventionelle PASS	10
2.2.4.	Spezielle Regelungen in Bezug auf Arzneimittel für neuartige Therapien	11
3.	Exkurs: Reformausblick (EU 6)	12
4.	Innerstaatliche Vorgaben (WD 8)	13
4.1.	Arzneimittelüberwachung nach innerstaatlichem Recht	13
4.2.	Systematik im innerstaatlichen Recht	14
4.2.1.	Nichtinterventionelle Unbedenklichkeitsstudien	14
4.2.2.	Interventionelle Unbedenklichkeitsstudien	15

1. Fragestellung, Begriffsbestimmung und Darstellungsumfang (EU 6)

Die Fachbereiche EU 6 und WD 8 wurden mit einer (unions-)rechtlichen Fragestellung zu Kohortenstudien¹ befasst. Konkret bittet der Auftraggeber um Darstellung der rechtlichen Grundlagen für die Nutzung von Kohortenstudien im Rahmen der **Pharmakovigilanz (Arzneimittelüberwachung)** neuartiger Humanarzneimittel².

Der Begriff der Pharmakovigilanz wird in dieser Arbeit als die laufende und systematische **Überwachung der Sicherheit**³ eines Fertigarzneimittels mit dem Ziel verstanden, dessen unerwünschte Wirkungen zu entdecken, zu beurteilen und zu verstehen, um entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen zu können.⁴ Diese Überwachung der Sicherheit bezieht sich auf **bereits zugelassene bzw. genehmigte Arzneimittel** (Nachmarktkontrolle).⁵

Die nachfolgende Darstellung beleuchtet zunächst den bestehenden unionsrechtlichen Regelungsrahmen, wobei das unionale Regelungssystem der Humanarzneimittelüberwachung skizziert wird und die innerhalb des Pharmakovigilanzsystems bestehenden Regelungen betreffend Kohortenstudien näher betrachtet werden (siehe zum Ganzen Ziff. 2). Hierzu wird in die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Durchführung von Unbedenklichkeitsstudien eingeführt, wobei zwischen nicht-interventionellen und interventionellen Studien unterschieden wird (siehe dazu Ziff. 2.2.2. und 2.2.3.). Anschließend wird überblicksartig der im Auftragskontext ggf. relevante Rechtsrahmen in Bezug auf neuartige Arzneimittel i. S. d. Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien⁶ skizziert (dazu Ziff. 2.2.4.). Abschließend erfolgt im Wege eines Exkurses ein Überblick zu bestehenden Reformbestrebungen, welche insbesondere auch die hier einschlägigen Regelungen betreffen könnten (dazu Ziff. 3.). Schließlich wird ein kurzer Überblick über die deutsche Rechtslage gegeben (dazu Ziff. 4., WD 8).

1 Siehe zu möglichen Studiendesigns: *Brockmüller*, in: Spickhoff/Handorn, Handbuch Medizinisches Forschungsrecht, 2024, § 3, Rn. 53 ff.

2 Der Begriff „neuartige Arzneimittel“ wird in dieser Arbeit untechnisch verwendet im Sinne neu zuzulassender bzw. zugelassener Arzneimittel. Die Auftragsfrage nimmt auf Impfstoffe gegen die Infektionskrankheit COVID-19 Bezug, die keine neuartigen Arzneimittel i. S. d. [Verordnung \(EG\) Nr. 1394/2007](#) darstellen (s. dazu überblicksartig Ziff. 2.2.4.).

3 Es wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher auf Studien eingegangen, die auf die Prüfung der Wirksamkeit eines Arzneimittels gerichtet sind, vgl. dazu etwa Art. 19 Buchst. f, Art. 22a [Richtlinie 2001/83/EG](#).

4 Vgl. *Kügel*, in: Clausen/Schroeder-Printzen, Münchener Anwaltshandbuch Medizinrecht, 4. Auflage 2026, § 18 Grundzüge des Arzneimittel- und Medizinprodukterechts, Rn. 212, unter Verweis auf die entsprechende Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

5 Vgl. *Streinz/Klaus*, in: Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Werkstand: 65. EL Januar 2026, § 13 Arzneimittelrecht, Rn. 152 f.

6 Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004, ABl. L 324 vom 10. Dezember 2007, S. 121 ([konsolidierte Fassung v. 26. Juli 2019](#)).

Die Arbeit beschränkt sich in unionsrechtlicher Hinsicht auftragsgemäß auf gesetzliche und regulatorische Grundlagen innerhalb der EU-Pharmakovigilanz. Auf potenziell einschlägige flankierende Vorgaben des EU-Rechts⁷ sowie Bestimmungen des sog. Soft Laws⁸ wird ausdrücklich nicht näher eingegangen.

2. Unionsrechtliche Vorgaben (EU 6)

2.1. Arzneimittelüberwachung nach dem Unionsrecht

Die Anforderungen der unionalen Humanarzneimittelüberwachung, d. h. der Nachmarktkontrolle, richten sich nach dem jeweils zu durchlaufenden Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren.⁹

Die **Richtlinie 2001/83/EG** (Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel, im Folgenden: RL 2001/83)¹⁰ enthält neben allgemeinen Vorschriften für Humanarzneimittel Vorgaben für dezentrale und **nationale Zulassungsverfahren**. Vorgaben zur Pharmakovigilanz finden sich im Wesentlichen im neunten Titel (Art. 101 ff.) der RL 2001/83/EG.

Die **Verordnung (EG) Nr. 726/2004** (im Folgenden: VO 726/2004)¹¹ regelt die zentrale Zulassung bestimmter Arzneimittel auf EU-Ebene. Vorgaben für die Arzneimittelüberwachung finden sich in Art. 21 ff. VO 726/2004. Gleichwohl werden wesentliche materiell-rechtliche Anforderungen aus der RL 2001/83/EG über Verweissnormen auch für zentral zugelassene Arzneimittel nach VO 726/2004 herangezogen.¹²

7 Kohortenstudien berühren aufgrund der mit ihnen verbundenen Datenerhebung insbesondere das europäische Datenschutzrecht, vgl. dazu *Caspar*, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 2. Auflage 2025, DS-GVO, Art. 89 Rn. 58 sowie *Buchner/Tinnefeld*, Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG, 4. Auflage 2024, DS-GVO, Art. 89, Rn. 17.

8 Auf Ebene des Soft Law strukturieren insbesondere die [Good-Pharmacovigilance-Practices-Leitlinien](#) (GVP) der EMA die praktische Durchführung von Unbedenklichkeitsstudien, namentlich die GVP-Module VI (Erfassung/Meldung von Nebenwirkungen) und VIII (Post-Authorisation Safety Studies). Methodisch-organisatorisch ergänzt wird dies u. a. durch den vom European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance veröffentlichten [Code of Conduct](#).

9 Vgl. EuGH, Urteil v. 11. April 2013, Rs. C-535/11, Novartis Pharma GmbH, Rn. 38; siehe *Streinz/Klaus*, in: Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Werkstand: 65. EL Januar 2026, § 13 Arzneimittelrecht, Rn. 154 ff. Die Begriffe „Zulassung“ und „Genehmigung“ werden synonym verwendet.

10 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel, ABl. L 311 v. 28. November 2001, S. 67 ff. ([konsolidierte Fassung v. 1. Januar 2025](#)).

11 Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur, ABl. L 136 vom 30. April 2004, S. 1 ff. ([konsolidierte Fassung v. 28. Januar 2022](#)).

12 Vgl. *Streinz/Klaus*, in: Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Werkstand: 65. EL Januar 2026, § 13 Arzneimittelrecht, Rn. 154.

Über diese beiden zentralen Rechtsakte hinaus enthält die **Verordnung (EU) Nr. 536/2014** (im Folgenden: VO 536/2014)¹³ spezielle Regelungen über **klinische Prüfungen** mit Humanarzneimitteln.

2.2. Unionsrechtliche Regelungen betreffend Kohortenstudien

Innerhalb des unionalen Systems der Pharmakovigilanz bestehen – soweit ersichtlich – keine spezifischen bzw. ausdrücklichen Regelungen in Bezug auf Kohortenstudien. Geregelt werden **Unbedenklichkeitsstudien nach der Genehmigung** bzw. Zulassung (im Folgenden: **PASS**¹⁴). Diese umfassen gemäß Art. 1 Nr. 15 RL 2001/83

„[j]ede Studie zu einem genehmigten Arzneimittel, die durchgeführt wird, um ein Sicherheitsrisiko zu ermitteln, zu beschreiben oder zu quantifizieren, das Sicherheitsprofil eines Arzneimittels zu bestätigen oder die Effizienz von Risikomanagement-Maßnahmen zu messen.“

Kohortenstudien zur Arzneimittelüberwachung dürften als methodischer Studientyp im Ausgangspunkt den betreffenden Regelungen über PASS unterfallen.

Es ist zwischen **interventionellen** und **nicht-interventionellen** (rein beobachtenden¹⁵) **PASS** zu unterscheiden. Interventionelle Prüfungen unterliegen den Anforderungen an klinische Prüfungen i. S. d. VO 536/2014.¹⁶ Klinische Prüfungen sind gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 2 VO 536/2014 klinische Studien¹⁷, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

(1) Der Prüfungsteilnehmer wird vorab einer bestimmten Behandlungsstrategie zugewiesen, die nicht der normalen klinischen Praxis des betroffenen Mitgliedstaats entspricht;

13 Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG, ABl. L 158 vom 27. Mai 2014, S. 1 ff. ([konsolidierte Fassung v. 5. Dezember 2022](#)).

14 PASS steht dabei für „Post Authorisation Safety Studies“.

15 Vgl. zum Begriff *Graf v. Westphalen/Antwerpes*, [Post-Authorisation Safety Study](#), DocCheck Flexikon.

16 *Listl-Nörr*, in: Spickhoff, Medizinrecht, 4. Aufl. 2022, § 40 AMG, Rn. 12; *Rehmann*, in: Rehmann, Arzneimittelgesetz (AMG), 6. Aufl. 2026, § 4 AMG, Rn. 46; *Wachenhausen*, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, § 4 AMG, Rn. 348 ff., auch zur Abgrenzung zur Anwendungsbeobachtung im nationalen Recht. Vgl. zur Abgrenzung auch: Gemeinsame Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und des Paul-Ehrlich Instituts zur Anzeige von Anwendungsbeobachtungen nach § 67 Absatz 6 Arzneimittelgesetz und zur Anzeige von nichtinterventionellen Unbedenklichkeitsstudien nach § 63f Arzneimittelgesetz, [15. Dezember 2022](#), wobei hier PASS teils ausschließlich als nichtinterventionelle Unbedenklichkeitsstudie eingestuft und von klinischen Prüfungen abgegrenzt werden.

17 Klinische Studien umfassen gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 VO 2014/536 jede am Menschen durchgeführte Untersuchung, die dazu bestimmt ist, (1) die klinischen, pharmakologischen oder sonstigen pharmakodynamischen Wirkungen eines oder mehrerer Arzneimittel zu erforschen oder zu bestätigen, (2) jegliche Nebenwirkungen eines oder mehrerer Arzneimittel festzustellen oder (3) die Absorption, die Verteilung, den Stoffwechsel oder die Ausscheidung eines oder mehrerer Arzneimittel zu untersuchen, mit dem Ziel, die Sicherheit und/oder Wirksamkeit dieser Arzneimittel festzustellen.

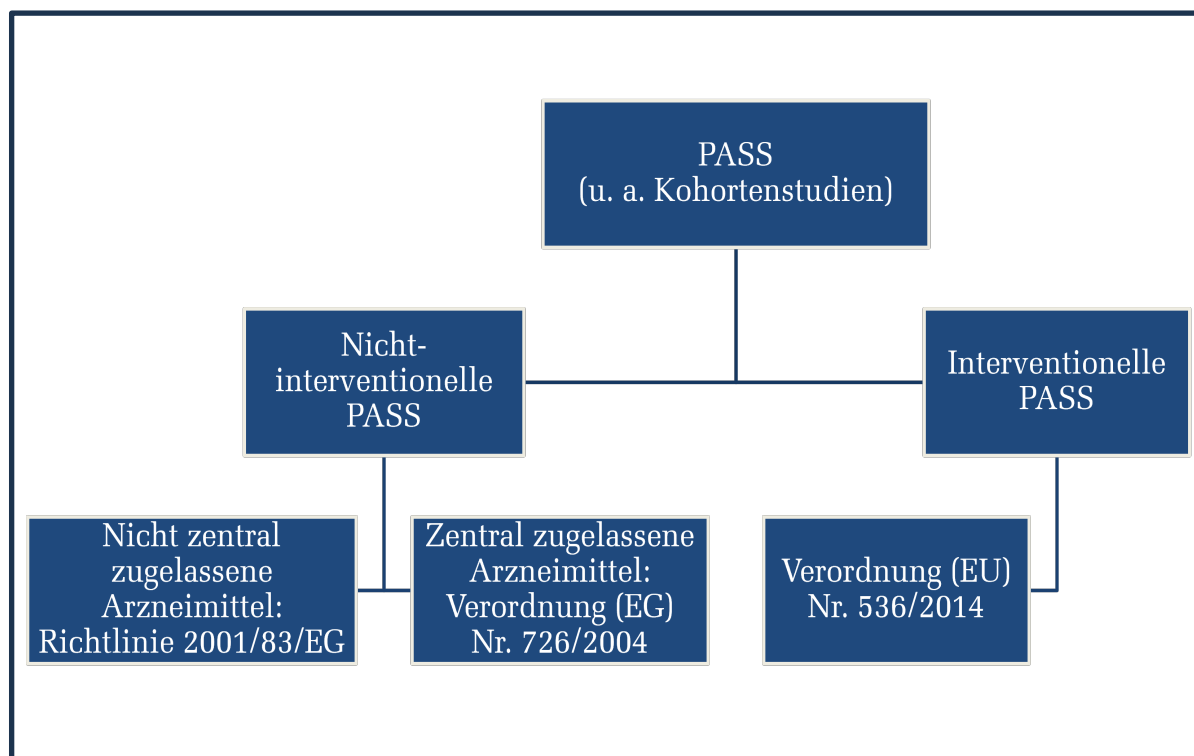
(2) die Entscheidung, die Prüfpräparate zu verschreiben, wird zusammen mit der Entscheidung getroffen, den Prüfungsteilnehmer in die klinische Studie aufzunehmen, oder

(3) an den Prüfungsteilnehmern werden diagnostische oder Überwachungsverfahren angewendet, die über die normale klinische Praxis hinausgehen.

Eine **nicht-interventionelle Studie** ist gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 VO 536/2014 hingegen jede **klinische Studie**, die **keine klinische Prüfung** ist.

Zur Abgrenzung zwischen interventionellen und nicht-interventionellen PASS ist demnach anhand der klinischen Praxis bzw. des konkreten Studiendesigns zu prüfen, ob eines der in Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 VO 536/2014 genannten Merkmale der klinischen Prüfung vorliegt.¹⁸ Kohortenstudien werden im Schrifttum als Beispiele für **nicht-interventionelle Beobachtungsstudien** genannt, weshalb der diesen zugrunde liegende Rechtsrahmen nachfolgend schwerpunktmäßig aufgezeigt wird.¹⁹

2.2.1. Überblick



¹⁸ Vgl. Koyuncu, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Auflage 2022, § 4 AMG, Rn. 226.

¹⁹ Vgl. Brockmöller, in: Spickhoff/Handorn, Handbuch Medizinisches Forschungsrecht, 2024, § 3, Rn. 53 ff.

2.2.2. Regelungsrahmen in Bezug auf nicht-interventionelle PASS

Nicht-interventionelle PASS unterliegen insbesondere den Regelungen der RL 2001/83 sowie der VO 726/2004. Zu unterscheiden ist insofern zwischen nicht zentral zugelassenen und zentral zugelassenen Arzneimitteln.

2.2.2.1. Nicht zentral zugelassene Arzneimittel – RL 2001/83

Die RL 2001/83 enthält Regelungen zu PASS für nicht zentral zugelassene Arzneimittel. Art. 21a und 22a RL 2001/83 sehen vor, dass die zuständige nationale Behörde eine Unbedenklichkeitsstudie bereits als Bedingung der (nationalen) Zulassung (Art. 21a Buchst. b RL 2001/83) oder nach der Genehmigung (Art. 22a Abs. 1 Buchst. a RL 2001/83) verbindlich anordnen kann, wenn Sicherheitsbedenken bestehen. Art. 22c RL 2001/83 verpflichtet den Genehmigungsinhaber, die Auflage in sein Risikomanagement-System aufzunehmen.

Art. 107m ff. RL 2001/83 regeln die „Überwachung von Unbedenklichkeitsstudien nach der Genehmigung“. Sie enthalten zentrale Vorgaben für nicht-interventionelle PASS,²⁰ wobei sonstige einzelstaatliche und unionsrechtliche Anforderungen im Hinblick auf das Wohlergehen und die Rechte der Teilnehmer von nicht-interventionellen PASS nach der Genehmigung unberührt bleiben, vgl. Art. 107 Abs. 2 RL 2001/83. PASS sind gemäß Art. 107m Abs. 3 RL 2001/83 nicht zulässig, wenn durch ihre Durchführung die Anwendung eines Arzneimittels gefördert werden soll. Art. 107m Abs. 4 – 6 RL 2001/83 regeln eine Vergütungsbeschränkung für die Teilnahme von Angehörigen der Gesundheitsberufe und Vorlagepflichten der Genehmigungsinhaber. Art. 107m Abs. 7 RL 2001/83 sieht das Erfordernis einer laufenden Überwachung der gewonnenen Daten im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Risiko-Nutzen-Verhältnis des betreffenden Arzneimittels und eine entsprechende Meldepflicht des Genehmigungsinhabers vor.

Die Art. 107n ff. RL 2001/83 sehen spezifische Regelungen für gemäß Art. 21a oder Art. 22a RL 2001/83 **behördlich auferlegte PASS** vor. Sie gelten nicht für freiwillige PASS. Im Ausgangspunkt steht dabei die Verpflichtung der Genehmigungsinhaber, den Entwurf des Studienprotokolls vorzulegen und nach einem bestimmten Verfahren genehmigen zu lassen (Art. 107n RL 2001/83). Nach Beginn einer Studie sind gemäß Art. 107o RL 2001/83 wesentliche Änderungen des Protokolls vor deren Umsetzung der zuständigen Stelle auf nationaler oder EU-Ebene vorzulegen, die diese billigt oder ablehnt. Art. 107p Abs. 1 RL 2001/83 statuiert eine grundsätzliche Pflicht des Genehmigungsinhabers zur Vorlage des abschließenden Studienberichts an die zuständige Stelle innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Datenerfassung. Gemäß Art. 107p Abs. 2 RL 2001/83 hat der Genehmigungsinhaber zu prüfen, ob sich die Studienergebnisse auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen auswirken und ggf. die Änderung der Genehmigung zu beantragen.

Art. 107q RL 2001/83/EG regelt das Verfahren zur Umsetzung von Studienergebnissen in regulatorische Maßnahmen, sofern für das Verfahren nach Art. 107n RL 2001/83 die EU-Stelle, d. h. der

20 Daneben besteht gemäß Art. 107b RL 2001/83 eine Pflicht zur Erstellung regelmäßiger Unbedenklichkeitsberichte, die auch Daten aus klinischen Prüfungen umfassen.

Ausschuss für Risikobewertung im Bereich Pharmakovigilanz²¹ zuständig ist. Dies ist gemäß Art. 107n Abs. 1 RL 2001/83 der Fall, wenn die Studie nicht nur in dem Mitgliedstaat durchgeführt werden soll, der dies nach Art. 22a RL 2001/83 verlangt hat. Der Ausschuss gibt gemäß Art. 107q Abs. 1 RL 2001/83 auf Grundlage der Studienergebnisse Empfehlungen zur Genehmigung, beispielsweise zur Änderung, Aussetzung oder zum Widerruf der Genehmigung. Art. 107q Abs. 2 RL 2001/83 bestimmt das nachfolgende Verfahren, in dem sich die in der Koordinierungsgruppe vertretenen Mitgliedstaaten (vgl. Art. 27 RL 2001/83) unter Berücksichtigung dieser Empfehlung auf einen gemeinsamen Standpunkt mit Umsetzungszeitplan einigen oder im Falle von Uneinigkeit das Verfahren an die Kommission weiterleiten.

Die Vorgaben der RL 2001/83 werden hinsichtlich **behördlich auferlegter**, nicht-interventioneller PASS ergänzt durch die **Durchführungs-VO (EU) 520/2012**²², welche insbesondere in Art. 36 ff. i. V. m. Anhang III Durchführungs-VO (EU) 520/2012 spezifisch-praktische Detailregelungen enthält (u. a. zum Format des Protokolls, der Zusammenfassung und des Abschlussberichts).

2.2.2.2. Zentral zugelassene Arzneimittel – VO 726/2004

Die VO 726/2004 enthält Regelungen für zentral auf EU-Ebene zugelassene Arzneimittel. Kernbestimmungen in Bezug auf PASS sind Art. 10, Art. 10a und 28b VO 726/2004.

Art. 10 Abs. 1 UAbs. 3 i. V. m. Art. 9 Abs. 4 Buchst. cb VO 726/2004 sieht – entsprechend Art. 21a RL 2001/83 – die Anordnung von Unbedenklichkeitsstudien nach der Genehmigung als Bedingung der Genehmigungserteilung vor.

Gleichlaufend zu Art. 22a RL 2001/83 sieht Art. 10a Abs. 1 Buchst. a VO 726/2004 die Möglichkeit seitens der Europäischen Arzneimittel-Agentur vor, dem Genehmigungsinhaber nach Erteilung der Zulassung die Verpflichtung aufzuerlegen, eine PASS durchzuführen, falls Bedenken hinsichtlich der Risiken eines genehmigten Arzneimittels bestehen.

Art. 28b VO 726/2004 überträgt das für national zugelassene Arzneimittel geltende PASS-Regime aus der RL 2001/83 im Wesentlichen auf zentral zugelassene Arzneimittel und ergänzt dieses in Art. 28 Abs. 2, Abs. 3 VO 726/2004. Art. 28b Abs. 1 VO 726/2004 sieht vor: „Für nichtinterventionelle Unbedenklichkeitsstudien nach der Genehmigung, die Humanarzneimittel betreffen, die gemäß dieser Verordnung genehmigt wurden und eines der in Artikel 10 und 10a dieser Verordnung genannten Kriterien erfüllen, gilt das in Artikel 107m Absätze 3 bis 7, Artikel 107n bis 107p und Artikel 107q Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG geregelte Verfahren“.

Die Art. 36 ff. Durchführungs-VO (EU) 520/2012 (s. Ziff. 2.2.2.1.) gelten auch für nach der VO 726/2004 angeordnete PASS.

21 Dies ist der für die Bewertung und Überwachung der Sicherheit von Humanarzneimitteln zuständige wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).

22 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 520/2012 der Kommission vom 19. Juni 2012 über die Durchführung der in der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Pharmakovigilanz-Aktivitäten, ABl. L 159 v. 20. Juni 2012, S. 5 ff. ([konsolidierte Fassung v. 12. Februar 2026](#)).

2.2.3. Regelungsrahmen in Bezug auf interventionelle PASS

Kohortenstudien, die nach der Genehmigung eines Arzneimittels erfolgen und ein interventionelles Design aufweisen, können als „klinische Prüfungen“ i. S. v. Art. 2 Nr. 2 VO 536/2014 unter die Regelungen dieser Verordnung fallen (s. Ziff. 2.1.). Die VO 536/2014 gilt gemäß ihrem Art. 1 für alle in der Union durchgeführten klinischen Prüfungen, nicht jedoch für nicht-interventionelle Studien.

Klinische Prüfungen müssen gemäß Art. 3 VO 536/2014 die Teilnehmer ausreichend schützen und für die Ermittlung zuverlässiger und belastbarer Daten konzipiert sein. Nach Art. 4 VO 536/2014 ist eine klinische Prüfung einer wissenschaftlichen und ethischen Überprüfung zu unterziehen und zu genehmigen. Die ethische Überprüfung erfolgt gemäß Art. 4 UAbs. 2 VO 536/2014 durch eine Ethik-Kommission gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaates.

Das Genehmigungsverfahren richtet sich nach Art. 5 ff. VO 536/2014. Das Verfahren wird gemäß Art. 5 Abs. 1 VO 536/2014 durch Antragstellung über ein EU-Portal ausgelöst. Daran schließt sich die Erstellung des **Bewertungsberichts Teil I** durch den vorher zu bestimmenden berichterstattenden Mitgliedstaat an. Gemäß Art. 6 Abs. 1 VO 536/2014 ist u. a. die Kompatibilität der klinischen Prüfung mit den materiellen Anforderungen für den Schutz der Teilnehmenden aus Kapitel V (Art. 28 ff.) VO 536/2014 in Bezug auf den erwarteten therapeutischen Nutzen und den Nutzen für die öffentliche Gesundheit sowie die Risiken und Nachteile für den Prüfungsteilnehmer zu prüfen. Hierbei sind jeweils bestimmte, in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b VO 536/2014 aufgeführte Aspekte zu berücksichtigen. Der berichterstattende Mitgliedstaat erstellt gemäß Art. 6 Abs. 2 VO 536/2014 einen Bewertungsbericht, der gemäß Art. 6 Abs. 3 VO 536/2014 eine Schlussfolgerung enthält, nach welcher die Durchführung der klinischen Prüfung entweder vertretbar, unter Auflagen vertretbar oder nicht vertretbar ist.

Daran schließt sich gemäß Art. 7 VO 536/2014 die Erstellung des **Bewertungsberichts Teil II** durch jeden betroffenen Mitgliedstaat für sein Hoheitsgebiet an. Die zu prüfenden Aspekte sind in Art. 7 VO 536/2014 im Einzelnen aufgelistet und betreffen insbesondere auch die Vorgaben zum Schutz der Teilnehmenden aus Kapitel V VO 536/2014.

Nach Art. 8 Abs. 1 VO 536/2014 teilt schließlich jeder betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor (Antragsteller) über das EU-Portal die **Entscheidung über die klinische Prüfung** mit, d. h., ob er die klinische Prüfung genehmigt, unter Auflagen genehmigt oder eine Genehmigung versagt. Das Verfahren, insbesondere, um von der Einschätzung des berichterstattenden Mitgliedstaats abzuweichen, ist in Art. 8 Abs. 2 ff VO 536/2014 geregelt.

Die in Kapitel V VO 536/2014 verankerten materiellen Bestimmungen zum Schutz der Prüfungsteilnehmer lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Eine klinische Prüfung darf gemäß Art. 28 Abs. 1 VO 536/2024 nur unter Einhaltung der in Art. 28 Abs. 1 Buchst. a – h VO 536/2024 aufgeführten Bedingungen durchgeführt werden. Vorausgesetzt wird demnach im Einzelnen, dass

- (1) der erwartete Nutzen für die Prüfungsteilnehmer oder für die öffentliche Gesundheit die vorhersehbaren Risiken und Nachteile rechtfertigt, und die Einhaltung dieser Bedingung ständig überwacht wird;

-
- (2) die Prüfungsteilnehmer, oder, falls ein Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher Vertreter gemäß Artikel 29 Absätze 2 bis 6 aufgeklärt worden sind;
 - (3) die Prüfungsteilnehmer, oder, falls ein Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher Vertreter eine Einwilligung nach Aufklärung gemäß Artikel 29 Absätze 1, 7 und 8 erteilt haben;
 - (4) das Recht der Prüfungsteilnehmer auf körperliche und geistige Unversehrtheit, Privatsphäre und Schutz der ihn betreffenden Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG gewahrt bleibt;
 - (5) die klinische Prüfung so geplant ist, dass sie mit möglichst wenig Schmerzen, Beschwerden, Angst und allen anderen vorhersehbaren Risiken für die Prüfungsteilnehmer verbunden ist und sowohl die Risikoschwelle als auch das Ausmaß der Belastung im Prüfplan eigens definiert und ständig überprüft werden;
 - (6) für die medizinische Versorgung der Prüfungsteilnehmer ein Arzt mit geeigneter Qualifikation oder gegebenenfalls ein qualifizierter Zahnarzt verantwortlich ist;
 - (7) die Prüfungsteilnehmer, oder, falls ein Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher Vertreter die Kontaktdaten einer Stelle erhalten haben, die ihnen gegebenenfalls weitere Informationen erteilt;
 - (8) die Prüfungsteilnehmer keiner unzulässigen Beeinflussung, etwa finanzieller Art, ausgesetzt werden, um sie zur Teilnahme an der Prüfung zu bewegen.

Darüber hinaus regelt Art. 29 VO 536/2014 die Einwilligung zur Teilnahme an der klinischen Prüfung, welche insbesondere nur nach einer Aufklärung erteilt werden kann, an welche ihrerseits besondere Anforderungen gestellt werden. Für bestimmte besonders schutzbedürftige Personengruppen (nicht einwilligungsfähige Personen, Minderjährige und schwangere bzw. stillende Frauen) und für Notfallsituationen statuieren die Art. 31 ff., 35 VO 536/2014 besondere Voraussetzungen.

2.2.4. Spezielle Regelungen in Bezug auf Arzneimittel für neuartige Therapien

Die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien (im Folgenden: VO 1394/2007)²³ enthält Vorschriften über die Pharmakovigilanz, die die Art. 21 ff. VO 726/2004 und damit auch Art. 28b VO 726/2004 i. V. m. Art. 107m ff. RL 2001/83 (s. dazu Ziff. 2.2.2.2.) ergänzen. „Arzneimittel für neuartige Therapien“ i. S. d. VO 1394/2007 umfassen gemäß Art. 1

23 Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004, ABl. L 324 S. 121 ff. ([konsolidierte Fassung v. 26. Juli 2019](#)).

Buchst. a VO 1394/2007 Genterapeutika, somatische Zelltherapeutika sowie biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte.²⁴

Die Art. 14 ff. VO 1394/2007 sehen strenge Regelungen zur Arzneimittelüberwachung vor. Gemäß Art. 14 Abs. 1 VO 1394/2007 ist der Antragsteller verpflichtet, in seinem Antrag auf Genehmigung für das Inverkehrbringen ausführlich die Maßnahmen zu erläutern, die er vorgesehen hat, um die **Nachbeobachtung** der Wirksamkeit und der **Nebenwirkungen** von Arzneimitteln für neuartige Therapien zu gewährleisten. Gemäß Art. 14 Abs. 2 VO 1394/2007 kann die Kommission bei einem besonderen Anlass zur Besorgnis auf Anraten der Agentur die Genehmigungsbedingung stellen, dass ein Risikomanagementsystem einschließlich einer Bewertung der Effizienz dieses Systems eingerichtet wird, durch das die Risiken in Verbindung mit Arzneimitteln für neuartige Therapien ermittelt, beschrieben, vermieden oder minimiert werden sollen, oder dass der Genehmigungsinhaber **spezifische Studien im Anschluss an das Inverkehrbringen** durchführt und der Agentur zur Prüfung vorlegt. Darüber hinaus kann die Agentur die Vorlage zusätzlicher Berichte fordern, die die Bewertung der Effizienz eines Risikomanagementsystems und die Ergebnisse derartiger Studien umfassen.

3. Exkurs: Reformausblick (EU 6)

Die Kommission hat im April 2023 Vorschläge zur Reform des EU-Arzneimittelrechts vorgelegt, welche auch das Recht der Arzneimittelüberwachung und die Regulierung von PASS betreffen. Die bestehende Systematik der Humanarzneimittelüberwachung soll dabei ausweislich der Kommissionsinitiative weitestgehend beibehalten und in neue Rechtsakte überführt werden. Im Wesentlichen beinhaltet die Initiative der Kommission im Hinblick auf den Auftragsgegenstand einen Richtlinienvorschlag²⁵ und einen Verordnungsvorschlag.²⁶ Die Verpflichtung zur Durchführung und die Überwachung von PASS in Bezug auf nicht-zentral zugelassene Arzneimittel ist in Art. 44, Art. 87 und Art. 117 ff. Richtlinienvorschlag geregelt und entspricht inhaltlich im Kern Art. 21a, 22a, 107m ff. RL 2001/83. Im Hinblick auf zentral zugelassene Arzneimittel ist insbesondere Art. 108 Verordnungsvorschlag maßgeblich, welcher seinerseits auf die betreffenden Regelungen des Richtlinienvorschlags verweist.

-
- 24 Hiervon nicht erfasst sind Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, die gem. Anhang I Teil IV Ziff. 2.1. RL 2001/83/EG insbesondere keine Genterapeutika darstellen. Dies gilt auch für Impfstoffe, die mRNA enthalten, da sie nur der Erzeugung einer Abwehrreaktion, d. h. der Inangasetzung der Antikörperbildung, dienen, um einer Infektionskrankheit vorzubeugen, vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 24. April 2024, 9 S 2412/22, Rn. 48.
- 25 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Unionskodexes für Humanarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/83/EG und der Richtlinie 2009/35/EG v. 26. April 2023, [KOM\(2023\) 192 endg.](#), im Folgenden: Richtlinienvorschlag.
- 26 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Verfahren der Union für die Zulassung und Überwachung von Humanarzneimitteln und zur Festlegung von Vorschriften für die Europäische Arzneimittel-Agentur, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 und der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 726/2004, der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 und der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 v. 26. April 2023, [KOM\(2023\) 193 endg.](#), im Folgenden: Verordnungsvorschlag.

Nachdem das Europäische Parlament und der Rat im Dezember 2025 eine vorläufige politische Einigung über das Regelungsvorhaben erzielt haben,²⁷ haben der AStV sowie der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments den Kompromisstext im März 2026 gebilligt.²⁸

4. Innerstaatliche Vorgaben (WD 8)

Schließlich soll im Folgenden das deutsche, innerstaatliche Regelungssystem der Arzneimittelüberwachung dargestellt werden. Dieses richtet sich maßgeblich nach den §§ 62 ff. Arzneimittelgesetz (AMG)²⁹, welche durch die dargestellten unionsrechtlichen Regelungen determiniert sind.³⁰

4.1. Arzneimittelüberwachung nach innerstaatlichem Recht

§ 4 Abs. 38 AMG definiert das Pharmakovigilanz-System als „*ein System, das der Inhaber der Zulassung und die zuständige Bundesoberbehörde anwenden, um insbesondere den im Zehnten Abschnitt aufgeführten Aufgaben und Pflichten nachzukommen, und das der Überwachung der Sicherheit zugelassener Arzneimittel und der Entdeckung sämtlicher Änderungen des Nutzen-Risiko-Verhältnisses dient.*“ Damit sollen die Sicherheit der Patienten und schließlich die öffentliche Gesundheit in Deutschland bewahrt werden.³¹

Bei Humanarzneimitteln trägt gemäß § 62 AMG die zuständige Bundesoberbehörde, also nach § 77 AMG entweder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)³², die Verantwortung für die behördliche Arzneimittelüberwachung und regelt die Zusammenarbeit mit anderen Stellen wie beispielsweise der EMA oder den Arzneimittelbehörden anderer Länder.

27 Rat der Europäischen Union, [Pressemitteilung](#) v. 11. Dezember 2025.

28 EU Law Tracker zu [2023/0132\(COD\)](#).

29 Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juni 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 195).

30 Siehe zur Umsetzung des EU-Pharmakovigilanz-Pakets *Schickert*, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, vor § 62 AMG, Rn. 11 sowie § 62 AMG, Rn. 1.

31 *Schickert*, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, vor § 62 AMG, Rn. 1.

32 Das BfArM ist für alle chemisch definierten sowie traditionellen und homöopathischen Arzneimittel zuständig, während das PEI bei Arzneimitteln, die aus Blut stammende Wirkstoffe enthalten, Impfstoffe, Arzneimittel mit Antikörpern, biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte, sowie Genterapeutika zuständig ist, vgl. *Schickert*, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, vor § 62 AMG, Rn. 20.

Handelt es sich um rein nationale Arzneimittelsicherheitsprobleme, sind die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten berechtigt, in ihre Rechtsordnungen eigenständige Maßnahmen aufzunehmen, wie es etwa mit dem deutschen Stufenplanverfahren³³ nach § 63 AMG geschehen ist.³⁴ Allerdings wird der Stufenplan bei Arzneimitteln, die zentral, dezentral oder nach dem Verfahren der gegenseitigen Anerkennung zugelassen wurden, von dem europäischen Pharmakovigilanz-Verfahren überlagert.³⁵

4.2. Systematik im innerstaatlichen Recht

Die grundlegenden Pflichten eines Zulassungsinhabers, die mit der Errichtung eines Pharmakovigilanz-Systems im deutschen Raum einhergehen, lassen sich in §§ 63a ff. AMG finden. Insbesondere § 63b AMG gibt die allgemeinen Pharmakovigilanz-Pflichten des Inhabers einer Zulassung wieder.³⁶

4.2.1. Nichtinterventionelle Unbedenklichkeitsstudien

Die gesetzlichen Vorgaben für **Kohortenstudien**, die als **nichtinterventionelle Unbedenklichkeitsstudien** (PASS) ausgeführt werden können³⁷, sind in §§ 63f und 63g AMG geregelt. Hier wird zwischen der vom Inhaber der Zulassung auf eigene Veranlassung **freiwillig** durchgeführten Studie, § 63f AMG, und der **behördlich angeordneten** Studie unterschieden, § 63g AMG. Die allgemeinen Voraussetzungen sind folgende:

- Anzeigepflicht gegenüber der zuständigen Bundesoberbehörde, § 63f Abs. 1 S. 1 AMG
- Vorlage des Protokolls und der Fortschrittsberichte, § 63f Abs. 1 S. 2 AMG
- Vorlage des Abschlussberichts, § 63f Abs. 1 S. 3 AMG

Die Durchführung von nichtinterventionellen Unbedenklichkeitsprüfungen ist nach § 63f Abs. 3 AMG dann **unzulässig**, wenn durch sie die Anwendung eines Arzneimittels gefördert werden soll, wenn sich Vergütungen für die Beteiligung von Angehörigen der Gesundheitsberufe an solchen Studien nach ihrer Art und Höhe nicht auf den Zeitaufwand und die angefallenen Kosten beschränken oder wenn ein Anreiz für eine bevorzugte Verschreibung oder Empfehlung be-

33 Der Stufenplan ist abrufbar unter https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_09022005_111436241.htm.

34 Schickert, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, vor § 62 AMG, Rn. 12.

35 Schickert, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, vor § 62 AMG, Rn. 12.

36 Siehe im Detail Schickert, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, § 63b AMG, Rn. 1 ff.

37 Eine Definition der Unbedenklichkeitsprüfung sieht § 4 Abs. 34 AMG vor: Eine Unbedenklichkeitsstudie ist jede Studie zu einem zugelassenen Arzneimittel, die durchgeführt wird, um ein Sicherheitsrisiko zu ermitteln, zu beschreiben oder zu quantifizieren, das Sicherheitsprofil eines Arzneimittels zu bestätigen oder die Effizienz von Risikomanagement-Maßnahmen zu messen.

stimmter Arzneimittel entsteht. Die Kriterien beziehen sich auf beide Arten der Unbedenklichkeitsstudien und gelten alternativ, sodass die Erfüllung eines Kriteriums zur Unzulässigkeit führt.³⁸

Für **behördlich angeordnete** nichtinterventionelle Unbedenklichkeitsstudien, vgl. §§ 63f Abs. 2 und 63g AMG, gelten die folgenden (strengerer) Voraussetzungen:

- Vorlage des Entwurfs eines Prüfungsprotokolls vor der Durchführung der Unbedenklichkeitsprüfung, § 63g Abs. 1 AMG
- Beginn der Studie erst nach Genehmigung der zuständigen Bundesoberbehörde, § 63g Abs. 2 AMG
- Übermittlung des Abschlussberichts innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Datenerfassung, § 63g Abs. 4 AMG

4.2.2. Interventionelle Unbedenklichkeitsstudien

Die klinischen Prüfungen³⁹ sind mit ihren Voraussetzungen in den §§ 40 ff. AMG geregelt. Die dortigen Verfahrensregelungen für die Genehmigung sind vollständig aus der VO 536/2014 entnommen, so dass auf die Ausführungen unter 2.2.3. verwiesen werden kann.

38 Wachenhausen, in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Aufl. 2022, § 63f AMG, Rn. 13.

39 Für die Abgrenzung zwischen der interventionellen und der nicht-interventionellen Unbedenklichkeitsstudie ist § 4 Abs. 23 S. 2 AMG hilfreich. Danach ist keine klinische Prüfung eine nichtinterventionelle Studie im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 536/2014. Siehe außerdem Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rahmenbedingungen für klinische Studien in ausgewählten Ländern, Sachstand vom 5. März 2026, WD 8- 3000 - 005/26, abrufbar unter <https://www.bundestag.de/resource/blob/1157816/WD-8-005-26.pdf>.